PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 17 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

17.1 Marco legal

O **Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)** foi instituído pela **Portaria GM/MS nº 529/2013**, com o objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em **todos os estabelecimentos de saúde** do território nacional. A **RDC ANVISA nº 36/2013** institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, tornando obrigatória a criação do **Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)** e a elaboração do **Plano de Segurança do Paciente (PSP)**.

Objetivos específicos do PNSP: promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente, por meio dos Núcleos de Segurança do Paciente; envolver pacientes e familiares; ampliar o acesso da sociedade às informações; produzir, sistematizar e difundir conhecimentos; fomentar a inclusão do tema no ensino técnico, de graduação e pós-graduação.

17.2 Conceitos (Portaria 529/2013 e RDC 36/2013)

Termo	Definição
Segurança do paciente	Redução, a um mínimo aceitável, do risco de **dano desnecessário** associado ao cuidado de saúde
Dano	Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção
Risco	Probabilidade de um incidente ocorrer
Incidente	Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente
Evento adverso	**Incidente que resulta em dano** ao paciente
Near miss (quase erro)	Incidente que **não atingiu** o paciente (foi interceptado antes)
Incidente sem dano	Incidente que **atingiu** o paciente, mas **não causou dano**
Circunstância notificável	Situação com potencial significativo de causar dano, sem que tenha ocorrido incidente (ex.: desfibrilador quebrado)
Cultura de segurança	Conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, **substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas**
Gestão de risco	Aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos

17.3 As seis metas internacionais de segurança do paciente

Os **protocolos básicos** do Ministério da Saúde (Portarias nº 1.377/2013 e nº 2.095/2013) correspondem às metas da OMS:

Meta	Protocolo	Principais ações
1. Identificar corretamente o paciente	Identificação do paciente	**Pulseira** de identificação (preferencialmente branca) com pelo menos **2 identificadores** (nome completo e data de nascimento ou nome da mãe/nº do prontuário); **nunca usar número do leito** ou do quarto; confirmar antes de qualquer procedimento, medicação, coleta, transfusão;

		pulseiras de cores podem indicar alergia ou risco de queda conforme o protocolo institucional
2. Melhorar a comunicação entre profissionais	Comunicação efetiva	Ordens verbais apenas em emergências, com **"leitura de volta" (read back)**; passagem de plantão estruturada (método **SBAR/ISBAR**: Situação, Breve histórico, Avaliação, Recomendação)
3. Melhorar a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos	Medicamentos	**9 certos**; dupla checagem de medicamentos de alta vigilância; evitar abreviaturas (como "U" para unidades); separação de medicamentos com nomes e embalagens semelhantes
4. Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos	Cirurgia segura	**Lista de Verificação de Cirurgia Segura** (Entrada, Pausa, Saída – ver Assunto 2); demarcação da lateralidade pelo cirurgião
5. Higienizar as mãos para evitar infecções	Prática de higiene das mãos	**5 momentos**; preparação alcoólica no ponto de assistência (ver Assunto 13)
6. Reduzir o risco de quedas e lesões por pressão	Prevenção de quedas e de lesão por pressão	Avaliação do risco de queda (escala de **Morse**) e de LPP (escala de **Braden**); grades elevadas, campainha ao alcance, iluminação, calçados antiderrapantes, acompanhante; mudança de decúbito a cada 2 h, hidratação da pele

Os 9 certos da medicação (protocolo do MS): paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, orientação certa, forma certa e resposta certa.

■ 17.4 Notificação de incidentes

Os eventos adversos devem ser notificados ao **Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)** pelo **NSP**, por meio do sistema **Notivisa**. Prazos (RDC 36/2013):

- **Eventos adversos com óbito:** notificação em até **72 horas** a partir do ocorrido.
- **Never events** (eventos que nunca deveriam ocorrer – como cirurgia em local ou paciente errado, retenção de corpo estranho, óbito ou lesão grave por erro de medicação, LPP estágio 3 ou 4): notificação em até 72 h e investigação.
- **Demais eventos adversos:** notificação até o **15º dia útil do mês subsequente** ao mês de ocorrência.

Qualquer profissional pode e deve comunicar incidentes ao NSP da instituição. A notificação tem caráter **educativo e não punitivo**, focado na melhoria dos processos (análise de causa raiz, protocolo de Londres, diagrama de Ishikawa). Pacientes e familiares também podem notificar (Notivisa – módulo cidadão).

■ 17.5 Atuação do técnico em enfermagem

- Conferir a identificação do paciente antes de **todo** cuidado.
- Aplicar os 9 certos e realizar dupla checagem nos medicamentos de alta vigilância.
- Comunicar e registrar incidentes e quase erros, sem medo de punição.
- Avaliar e registrar o risco de queda e de LPP, executando as medidas preventivas prescritas.
- Higienizar as mãos nos 5 momentos.

▸ Orientar e envolver o paciente e a família na própria segurança (perguntar o nome, informar alergias, chamar ajuda para levantar).

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

▸ Portaria 529/2013 (PNSP) e RDC 36/2013 (NSP e PSP).
▸ Conceitos: incidente, evento adverso, near miss, incidente sem dano, circunstância notificável.
▸ As 6 metas e os protocolos correspondentes.
▸ Pulseira com 2 identificadores; nunca o número do leito.
▸ Ordem verbal com leitura de volta; SBAR.
▸ Escala de Morse (quedas) e de Braden (LPP).
▸ Notificação pelo Notivisa: óbito em 72 h; demais até o 15º dia útil do mês seguinte.
▸ Cultura de segurança não punitiva.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

▸ **"6 metas: I-C-M-C-H-Q"**: Identificação, Comunicação, Medicamentos, Cirurgia, Higiene das mãos, Quedas e LPP.
▸ **"Evento adverso dói"**: é o incidente que causou dano.
▸ **"Near miss passou raspando"**: não chegou ao paciente.
▸ **"Leito muda, nome não"**: nunca identificar pelo leito.
▸ **"Morse cai, Braden machuca a pele"**.
▸ **"Óbito em 72 h"** de notificação.
▸ **"SBAR: Situação, Breve histórico, Avaliação, Recomendação"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

O técnico em enfermagem preparou o medicamento para o paciente errado, mas percebeu o erro ao conferir a pulseira de identificação, antes da administração. Segundo a classificação de incidentes, trata-se de:

(A) evento adverso.
(B) near miss (quase erro).
(C) incidente sem dano.
(D) circunstância notificável.
(E) never event.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o evento adverso é o incidente que resulta em dano.

B) Correta – o incidente foi interceptado e não atingiu o paciente: near miss.

C) Incorreta – o incidente sem dano atinge o paciente, mas não causa dano.

D) Incorreta – a circunstância notificável não envolve incidente.

E) Incorreta – o medicamento não chegou a ser administrado.

QUESTÃO 02

Segundo o protocolo de identificação do paciente, é correto afirmar:

(A) o número do leito é um identificador seguro e suficiente.
(B) a pulseira deve conter pelo menos dois identificadores, como nome completo e data de nascimento, e ser conferida antes de qualquer procedimento.
(C) pacientes conscientes dispensam a pulseira de identificação.
(D) a conferência da identificação deve ser feita apenas na admissão.
(E) a pulseira deve conter apenas o diagnóstico médico.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o leito nunca deve ser usado como identificador.

B) Correta – são exigidos ao menos dois identificadores e a conferência antes de cada cuidado.

C) Incorreta – todos os pacientes internados devem usar pulseira.

D) Incorreta – a conferência deve ocorrer antes de cada procedimento.

E) Incorreta – o diagnóstico não é identificador e expõe o paciente.

QUESTÃO 03

A instituição do Núcleo de Segurança do Paciente nos serviços de saúde tornou-se obrigatória com a:

(A) Lei nº 8.080/1990.
(B) RDC ANVISA nº 36/2013.
(C) Portaria nº 1.820/2009.
(D) NR 32.
(E) Lei nº 7.498/1986.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a Lei 8.080/1990 é a Lei Orgânica da Saúde.

B) Correta – a RDC 36/2013 determina a criação do NSP e do Plano de Segurança do Paciente.

C) Incorreta – a Portaria 1.820/2009 trata dos direitos dos usuários.

D) Incorreta – a NR 32 trata da segurança do trabalhador.

E) Incorreta – a Lei 7.498/1986 regula o exercício da enfermagem.

QUESTÃO 04

A escala utilizada para avaliar o risco de quedas em pacientes hospitalizados é a escala de:

(A) Braden.
(B) Glasgow.
(C) Morse.
(D) Apgar.
(E) Aldrete e Kroulik.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – Braden avalia o risco de lesão por pressão.

B) Incorreta – Glasgow avalia o nível de consciência.

C) Correta – a escala de Morse avalia o risco de quedas.

D) Incorreta – Apgar avalia a vitalidade do recém-nascido.

E) Incorreta – Aldrete e Kroulik avaliam a recuperação pós-anestésica.

QUESTÃO 05

Em relação à notificação de eventos adversos, segundo a RDC ANVISA nº 36/2013, é correto afirmar:

(A) eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 horas a partir do ocorrido.
(B) a notificação tem caráter punitivo e serve para identificar o profissional culpado.
(C) apenas os médicos podem comunicar incidentes ao NSP.

(D) eventos adversos sem óbito não precisam ser notificados.

(E) a notificação deve ser feita ao Conselho Regional de Enfermagem.

✔️ **GABARITO: A**

Comentário:

A) Correta – eventos com óbito são notificados em até 72 h; os demais até o 15º dia útil do mês subsequente.

B) Incorreta – a cultura de segurança é não punitiva e voltada à aprendizagem.

C) Incorreta – qualquer profissional pode e deve comunicar incidentes.

D) Incorreta – todos os eventos adversos devem ser notificados.

E) Incorreta – a notificação é feita ao SNVS pelo Notivisa.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: PNSP (Portaria 529/2013); RDC 36/2013 (NSP e PSP); conceitos; seis metas e protocolos; 9 certos; notificação (Notivisa e prazos); cultura de segurança; atuação do técnico.

Quadro-resumo: 6 metas; 2 identificadores; SBAR; Morse – quedas; Braden – LPP; óbito – notificação em 72 h; demais – até o 15º dia útil do mês seguinte.

Pegadinhas: chamar near miss de evento adverso; identificar pelo leito; achar que a notificação é punitiva.

Erros comuns: confundir Morse e Braden; trocar a Portaria 529/2013 pela RDC 36/2013.